

מדיניות המרכז הרפואי הדסה נוהל העבודה ביחידת הטראומה בהדסה עין כרם מספר: 02-05-06-01			
הספר: 02, שרותי רפואה		התחום: 05, חדרי מיון ורפואת חירום	
הנושא: 06, יחידת הטראומה		הנוהל: 01, העבודה ביחידת הטראומה בהדסה עין כרם	
מהדורה: שניה		עדכון: דצמבר 2024	עמוד 1 מתוך 17
הנוהל עודכן ע"י: פנינה שרון מנהלת חטיבה, פרופ' מיקלוש באלה מנהל יחידת הטראומה, דר' אסף קידר רופא בכיר יחידת הטראומה, מרב קמר מ"מ אחות ראשית מלר"ד ע"כ, שלומית אטלו ראש צוות טראומה ע"כ, בר הוטרר הורביץ מ"מ ראש צוות טראומה ע"כ. הנוהל אושר ע"י: פרופ' יניב שרר מנהל בית החולים ע"כ, דר' רלי אלון סמנכ"לית סיעוד ומקצועות הבריאות, דר' אחמד נעמה מנהל המחלקה לרפואה דחופה ע"כ, פרופ' אלון פיקרסקי מנהל האגף הכירורגי, פרופ' מיקלוש באלה מנהל יחידת הטראומה, דר' אסף קידר רופא בכיר יחידת הטראומה, דר' סער חשביה מנהל מלר"ד ילדים, פרופ' דוד שויקי מנהל אגף נשים ומיילדות. גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה שיפמן מנהלת תחום נהלים וסטנדרטים מקצועיים, המערך לאיכות ובטיחות. תחומי האקרדיטציה: COP 3 (JCI מהדורה 7)			

1. סימוכין

- 1.1. ספר: Resources for Optimal Care of Injured Patient, ACS.
<https://www.facs.org/-/media/files/quality-programs/trauma/vrc-resources/resources-for-optimal-care.ashx>
- 1.2. משרד הבריאות: חוזר חטיבת רפואה, בנושא: [אמות מידה להכרה במרכז טראומה](#), מספר: 10/2019.
- 1.3. הדסה: [נוהל נטילת דגימות דם לשם קביעת סוג, הזמנת דם ומתן דם לחולים](#), מספר: 02-10-01-06.
- 1.4. הדסה: [נוהל העברת מטופל במצב קריטי בין יחידות בית החולים](#), מספר: 02-02-11-05.
- 1.5. הדסה: [נוהל העברת מטופל במצב קריטי בין בתי החולים של הדסה](#), מספר: 02-02-11-07.
- 1.6. הדסה: [נוהל קבלה וטיפול במטופל במחלקה לרפואה דחופה \(מלר"ד\)](#), מספר: 02-05-02-01.
- 1.7. הדסה: [נוהל לאיתור זיהוי קטינים וחסי ישע נפגעי אלימות במשפחה - חובת הודעה והעברת מידע בין מוסדות רפואיים](#), מספר: 02-12-02-03.
- 1.8. הדסה: [נוהל זיהוי מטופל בבית החולים](#), מספר: 02-12-04-01.
- 1.9. הדסה: [פק"ל ארן](#) 2024
- 1.10. הדסה: [הנצלת אברים ורקמות](#), מספר: 02-20-04-01.

2. נספחים

- 2.1. נספח 1: [עמדות צוות הטראומה ביחידת הטראומה](#).
- 2.2. נספח 2: [טופס מעקב יחידת הטראומה](#) (מק"ט: 8007-0).
- 2.3. נספח 3: [Let's Roll רגע לפני העברת מטופל קריטי](#).
- 2.4. נספח 4: [רשימת תיוג ושחרור מחדר הטראומה](#) (מק"ט: 8006-0).
- 2.5. נספח 5: [קריטריונים לקבלת פצוע לטראומה ACC 2.3 ME 1](#).
- 2.6. נספח 6: [קריטריונים לקריאה לעובדת סוציאלית-לחדר הטראומה](#).
- 2.7. נספח 7: [בדיקות דם בחדר טראומה](#).
- 2.8. נספח 8: [רשימת תיוג טרם יציאת פצוע מהטראומה](#) (מק"ט: 8061-0).
- 2.9. נספח 9: [טופס דיווח קבלת פצוע](#).
- 2.10. נספח 10: [דיווח על נחיתת מסוק](#).
- 2.11. נספח 11: [תאור תפקיד מתאמת טראומה](#).
- 2.12. נספח 12: [דווח על מתן דם ומרכזי דם בחדר טראומה](#).



2.13. נספח 13: [עדכוני המהל](#).

3. מבוא

- 3.1. חדר הטראומה אשר ממוקם במרכז לרפואה דחופה משמש להערכה וטיפול בפצועים. על מנת להבטיח טיפול נכון ומיטבי בפצועים, גובש הנוהל הבא על ידי צוות היחידה לכירורגיה דחופה והטראומה. נוהל זה מגדיר את התפקידים של חברי צוות הטראומה, מדיניות טיפול בפצועים ונושאים אחרים החיוניים להפעלת חדר הטראומה.
- 3.2. חדר הטראומה אשר משמש להערכה וטיפול בפצועים מופעל בעזרת צוותים שונים ממסגרות בית החולים תוך הנחיית הצוות לכירורגיה דחופה וטראומה.
- 3.3. באירוע רב נפגעים משמש חדר הטראומה לטיפול בפצועים דחופים לפי פרוטוקול אר"ן.

4. מטרה

- 4.1. קביעת כללים אחידים לקבלת פצוע לחדר הטראומה ולהפעלת צוות הטראומה.
- 4.2. הגדרת תפקידי צוות יחידת הטראומה ורופאים ואחיות מהיחידות השונות העוסקים בטיפול בפצוע בחדר הטראומה.
- 4.3. הגדרת הפעולות הנדרשות בשגרה לאבטחת איכות הטיפול ביחידת הטראומה, עם שמירת זכויות הפצוע וכבודו.

5. חלות

- 5.1. מנהלת חטיבה מלר"ד, אחות ראשית מלר"ד, אחיות, רופאים, מנהלי יחידות טיפול נמרץ ורפואה דחופה, מנהלי אגפים ומחלקות.

6. סמכות ואחריות

- 6.1. בסמכות מנהל היחידה לכירורגיה דחופה וטראומה להחליט על נהלים וסדר הפעילות ביחידת הטראומה.
- 6.2. באחריות אחות ראש צוות טראומה להפעיל את היחידה בשגרה.
- 6.3. בסמכות אחות ראשית מלר"ד/ראש צוות טראומה/אחות אחראית משמרת/כירורג, לאשר קבלת פצוע/ים לחדר הטראומה.
- 6.4. באחריות צוות הטראומה לנהל את הטיפול בפצוע: הכנת חדר הטראומה לקבלת הפצוע טרם הגעתו, הטיפול ביחידת הטראומה וכן המשך ברור וטיפול לאחר יציאת המטופל מחדר הטראומה.
- 6.5. באחריות צוות הטראומה לדאוג לטיפול מיטבי והמשכי בעזרת כח האדם והציוד המתאימים ביותר לצרכיו של הפצוע.
- 6.6. באחריות כונן מיון כירורגיה (או מי מטעמו), לדאוג להתנהלות צוות הטראומה בעת הטיפול בפצוע ומסירת המידע למטופל ומשפחתו.
- 6.7. באחריות האחות המופקדת לטראומה בעת משמרת, לדאוג שהיחידה תהיה מוכנה בכל עת לקליטת פצוע.

7. הגדרות

- 7.1. "פצוע": אדם שעבר טראומה גופנית כתוצאה מפגיעה ממקור חיצוני.
- 7.2. "היחידה לכירורגיה דחופה וטראומה": הינה חלק מהמערך לרפואה דחופה ומורכבת מ:
 - 7.2.1. מנהל יחידת הטראומה.
 - 7.2.2. רופאים בכיר/ים.



7.2.3. אחות ראש צוות טראומה.

7.2.4. אחיות מתאמות טראומה ([הגדרת תפקיד](#)).

7.2.5. רשמת טראומה.

7.2.6. בת שרות.

7.3. "חדר טראומה": אזור ייעודי במלר"ד עבור הערכה וטיפול בפצועים עם מאפיינים ייחודיים עפ"י [חוזר](#)

[חטיבת רפואה במשרד הבריאות](#). חדר הטראומה ערוך בכל עת לטפל בעד 12 פצועים בו זמנית כולל ילדים

ותינוקות.

7.4. "צוות טראומה": צוות רב מקצועי המטפל בפצוע/ים. תפקידיו: מוכנות, קבלה, הערכה וטיפול מיטבי ובטוח

בפצוע/ים.

7.4.1. צוות טראומה קבוע:

7.4.1.1. כירורג תורן ראשון.

7.4.1.2. אורתופד תורן ראשון.

7.4.1.3. נירוכירורג: תורן מיון.

7.4.1.4. אחות טראומה: המופקדת בכל משמרת.

7.4.1.5. רדיולוג.

7.4.1.6. רופא מלר"ד.

7.4.1.7. טכנאי רנטגן.

7.4.1.8. פקיד קבלת חולים.

7.4.1.9. מוקדן (למעט בשעות הלילה).

7.4.2. צוות טראומה מורחב:

7.4.2.1. צוות טראומה קבוע ובנוסף:

- שני מרדימים (אחד מהם מרדים ביניים).

- כירורג תורן שני.

- אחות נוספת מהמלר"ד.

7.4.3. צוות נוסף לפי הצורך.

7.4.4. במקרה של אישה בהריון:

7.4.4.1. גינקולוג.

7.4.4.2. החל משבוע 24 להריון ניתן לזמן גם מיילדת במקרה הצורך.

7.4.5. במקרה של ילד מתחת לגיל 17:

7.4.5.1. מלר"ד ילדים ו/או רופא טיפול נמרץ ילדים ו/או כירורג ילדים.

7.4.5.2. ניתן לזמן גם אחות מלר"ד ילדים.

7.5. "תורן כירורגיה ראשון (בכיר)": מתמחה מהמחלקה לכירורגיה כללית אשר קיבל הרשאה ע"י מנהל

המחלקה הכירורגית להיות תורן ראשון כירורגיה במלר"ד. תורן זה יהיה זמין בכל עת לחדר הטראומה,

החל מההודעה הטלפונית ועד סיום הטיפול בפצוע/ים.

7.6. "תורן כירורגיה שני (ג'וניור)": מתמחה מהמחלקה לכירורגיה כללית אשר קיבל הרשאה ע"י מנהל

המחלקה הכירורגית להיות תורן שני כירורגיה במלר"ד. תורן זה יהיה זמין בכל עת לחדר הטראומה, החל

מההודעה הטלפונית ועד סיום הטיפול בפצוע/ים.



- 7.7. "כונן טראומה (מיון)": מומחה בכירורגיה אשר קיבל הרשאה ע"י מנהל המחלקה הכירורגית להיות כונן כירורגיה בבית החולים. הכונן יהיה זמין בכל עת לחדר הטראומה, החל מההודעה הטלפונית ועד סיום הטיפול בפצוע/ים.
- 7.8. "ראש צוות טראומה": אחות בוגרת הכשרה על בסיסית ברפואה דחופה, בעלת אחריות וסמכות ניהולית בחדר הטראומה – בנ"ל נכללים ניהול שוטף של היחידה, העשרת הצוות הסיעודי ע"פ הגדרת התפקיד, ([הגדרת תפקיד](#)).
- 7.9. "מתאמת טראומה": ראה הגדרת תפקיד [נספח 11](#).
- 7.10. "אחות טראומה": אחות מהמחלקה לרפואה דחופה שעברה הכשרה ייעודית, המופקדת במשמרת לחדר הטראומה ואחראית על הטיפול הסיעודי בפצוע עד הגעתו לאתר הטיפול הבא.
- 7.11. "אחראית משמרת": אחות המנהלת את המשמרת במקומה של האחות הראשית במחלקה לרפואה דחופה.
- 7.12. "גורם מפנה": פניה עצמית, ארגוני הצלה שונים, יחידות חילוץ צבאיות ואזרחיות, צה"ל.
- 7.13. "אלמוני": חולה/נפגע שאינו מסוגל למסור פרטים מזהים ולא ניתן לאתר מסמכים או פרטים מזהים ודאיים שיצביעו על זהותו. האלמוני מקבל מספר זמני וגם מספר "ברזל" (מספר שאינו משתנה ומאפשר לאתר את המטופל גם לאחר זיהוי ודאי שלו ושינוי מס' הרשומה הזמני לקבוע).
- 7.14. "MIST": MECHANISM INJURY SIGNS TREATMENT עקרונות שיטת העברת דיווח מהשטח לצוות טראומה לקבלת פצוע.
- 7.15. "ATLS": שיטת טיפול מתקדמת לנפגעי טראומה גופנית.

8. שיטה

8.1 מדיניות כללית:

- 8.1.1. צוות הטראומה יופעל בכל קבלת פצוע לחדר טראומה.
- 8.1.2. במקרה של העברת פצוע מבית חולים אחר:
- 8.1.2.1. העברה תאושר ע"י כונן טראומה וידווח למנהל היחידה לכירורגיה דחופה וטראומה.
- 8.1.2.2. ההעברה תעשה בלווי מכתב סיכום מהמוסד המעביר וכן תוצאות כלל הבדיקות וההדמיות אשר בוצעו. את ההדמיות יש להעלות למערכת בית החולים.
- 8.1.3. באחריות תורן כירורגיה ראשון ואחות טראומה להנחות ולוודא היערכות נכונה בחדר הטראומה לאחר קבלת הדיווח על פצוע וטרם הגעתו.
- 8.1.4. הטיפול בפצוע יעשה ע"פ עקרונות ה-ATLS.
- 8.1.5. העברת פצוע מחדר הטראומה מחייבת ליווי של צוות מטפל עפ"י [נוהל העברת מטופל קריטי](#), מספר: 02-02-11-05, העברה ללא ליווי באישור מוביל צוות טראומה.
- 8.1.6. יציאת פצוע מחדר טראומה מחייבת אישור של תורן כירורגיה ראשון.
- 8.1.7. לכל פצוע אשר טופל בחדר הטראומה, יש לכתוב סיכום מסודר הכולל את כלל האבחנות (ע"פ ICD), הערכה והטיפול שבוצע, כולל חתימת הרופא (באחריות מוביל צוות טראומה).
- 8.1.8. פצועים מאושפדים, יעברו סקר שלישוני על ידי צוות יחידת הטראומה במהלך 24 השעות הראשונות לאחר אשפוזם.

8.2 הגדרות תפקיד:

- 8.2.1. תורן כירורגיה ראשון: כל פצוע הנכנס לטראומה ייבדק ע"י כירורג תורן ללא קשר למנגנון או למיקום הפציעה. באחריותו:



8.2.1.1. ניהול הטיפול הרפואי והובלת הצוות המטפל.

8.2.1.2. תיאום וריכוז כל הצוותים המטפלים בפצוע.

8.2.1.3. פיקוח על פעילויות התורנים אחרים.

8.2.1.4. דיווח לכונן. במידה וכונן הטראומה אינו בביה"ח, באחריות תורן הכירורגיה לדווח לו.

8.2.1.5. בעת סיום תפקידו יבצע העברה מסודרת לתורן כירורגיה ראשון המחליף אותו.

8.2.2. תורן כירורגיה שני, באחריותו:

8.2.2.1. עובד תחת פיקוח והנחיית תורן כירורגיה ראשון ו/או כונן כירורגיה.

8.2.2.2. עפ"י הצורך, ממלא את מקום תורן כירורגיה ראשון בטיפול בפצועים ובכך מוביל את

הטיפול, אין הנאמר מוריד מאחריותו של מוביל צוות טראומה.

8.2.2.3. עובד כחלק מצוות טראומה מורחב.

8.2.2.4. בכל מקרה טראומה מדווח לתורן ראשון ו/או כונן כירורגיה.

8.2.2.5. כונן טראומה (כונן כירורגיה מיון):

- אחראי על מתן מענה הולם לפצוע והוא הסמכות בכל הקשור לקבלת החלטות הנוגעות לטיפול בפצוע.
- כאשר נוכח, כונן הטראומה ינהל ויוביל את צוות הטראומה ויסייע לכלל בעלי התפקידים בטיפול בפצוע.
- על-פי הצורך, ייוועץ כונן הטראומה עם מנהל היחידה לכירורגיה דחופה וטראומה ו/או מנהל המחלקה לכירורגיה כללית.
- הכונן ישוחח בעצמו או יוודא שרופא/ה משוחח עם קרובי המשפחה של הפצוע.
- בעת הצורך כונן הטראומה יהיה נוכח תוך 30 דקות או פחות בבית החולים (בחדר הטראומה / חדר ניתוח / אחר).
- נוכחות כונן טראומה נדרשת באופן מיידי (תוך 30 דקות או פחות) במקרים הבאים:
 - פצוע בתמונה קלינית של שוק דימומי (Hemorrhagic shock).
 - פציעה בדרכי אויר או קושי בניהול נתיב אויר.
 - פציעה חודרת בצוואר.
 - כל פציעת ירי לגו (טורסו).
 - בכל פגיעה מפיצוץ (פגיעת גל הדף).
 - כאשר ישנם 2 פצועים ומעלה בו זמנית בהתאם להחלטת תורן ראשון.
 - על-פי דעתו של כונן כירורגיה ו/או תורן כירורגיה ראשון.

8.2.3. תפקיד האחות בחדר טראומה:

8.2.3.1. אחראית על בדיקת חדר הטראומה בתחילת משמרת והכנת חדר הטראומה לקליטת

הפצוע מיד לאחר הדיווח וטרם הגעתו.

8.2.3.2. אחראית לניהול העבודה הסיעודית ולוויסות כוח האדם.

8.2.3.3. אחראית לביצוע זיהוי מטופל והענידת ידון.

8.2.3.4. אחראית לטיפול בפצוע:

- ניטור מתמשך של הפצוע מקבלתו ועד יציאתו מחדר הטראומה.
- הקפדה על בטיחות הפצוע.
- שמירה על צנעת הפרט.
- ביצוע הפשטה מלאה.



- איסוף וסימון הבגדים והחפצים האישיים.
- במקרה של פצוע שאינו מסוגל להשגיח על חפציו האישיים, יש להפקידם על פי נוהל הפקדת חפצי ערך מספר: 01-24-04-01.
- חימום הפצוע.
- סיוע בפרוצדורת רפואיות על-פי צורך.
- ניקוי הפצוע והקפדה על מצעים וכיסוי יבשים ונקיים.
- שטיפה וחבישת פצעים, עזרה בקיבועים.
- 8.2.3.5. אחראית על הכנת הפצוע להעברה.
- 8.2.3.6. אחראית על קשר עם בנק הדם ושחרור מוצרי דם.
- 8.2.3.7. ווידוא יצירת קשר עם משפחת הפצוע.
- 8.2.3.8. עזרה בדאגה למשפחה: מידע, רווחה וצרכים אחרים.
- 8.2.3.9. דיווח לעו"ס על-פי קריטריונים [בנספח 6](#).
- 8.2.3.10. ווידוא הפעלת יחידת יק"ר (ר"מ 2) כאשר מדובר בחייל.
- 8.2.3.11. ווידוא העברת בדיקות למעבדה:
 - רישום ברשומה הסייעודית.
 - תיאום מול הגורם המקבל: CT / אחות אחראית משמרת / טיפול נמרץ / חדר ניתוח.
 - תיעוד בספר טראומה.
 - ווידוא כי דם או מוצרי דם שלא ניתנו חוזרים לבנק הדם ומועבר טופס דיווח שימוש בדם ([נספח 12](#)).
 - אחראית להחזרת חדר הטראומה למוכנות לקליטת פצוע/ים נוספים במהירות האפשרית.
- 8.2.4. דיווח לבעלי תפקידים:
 - 8.2.4.1. יש להודיע מייד לכונן טראומה (כירורגיה מיון) במקרים הבאים:
 - כל פצוע עם הקריטריונים לנוכחות כונן טראומה (כירורגיה).
 - פציעה חודרת בחזה ו/או בבטן ו/או אגן ו/או מפשעות.
 - פציעה באגן עם קיפוח המודינמי.
 - פציעות בעמוד השדרה עם חסרים ניירולוגים.
 - פציעת גפה עם חסר ניירו-וסקולרי.
 - בכל פרוצדורה פולשנית בפצוע.
 - כל פצוע שנלקח לחדר הניתוח (ללא קשר לסיבה/דיסציפלינה מנתחת).
 - 8.2.4.2. דיווחים למנהל היחידה לכירורגיה דחופה וטראומה:
 - בכל העברת פצוע מבית חולים אחר.
 - בכל פצוע בתמונה של שוק דימומי. (Hemorrhagic shock)
 - בכל מקרה של קושי בהערכת הפצוע או בטיפול בו על-פי שיקול כונן כירורגי.
 - בכל אירוע חריג במהלך ההערכה והטיפול בפצוע.
 - בכל פטירה של פצוע בחדר הטראומה.
 - בהתאם לשיקול דעתו של מוביל צוות טראומה ו/או כונן כירורגיה.



- בהעדר מנהל היחידה לכירורגיה דחופה וטראומה יש לדווח למנהל המחלקה הכירורגית.

8.2.4.3. דיווחים למנהל המחלקה לרפואה דחופה:

- בכל פטירה של פצוע בחדר הטראומה.
- בכל מקרה של תקלה ו/או עיכוב בפינוי פצוע מחדר הטראומה.
- בכל פגיעה כתוצאה מפח"ע.

8.2.4.4. דיווח לאחות ראש צוות טראומה:

- בכל מקרה של חוסר ו/או תקלה בציוד בחדר הטראומה.
- בשימוש בציוד מיוחד במהלך הטיפול בפצוע.
- בכל אירוע חריג במהלך הערכה והטיפול בפצוע.
- בכל פטירה של פצוע בטראומה.
- בכל מקרה בו אחמ"ש רואה לנכון.

8.2.4.5. דיווח לאחות ראשית של המלר"ד:

- בכל אירוע חריג במהלך הערכה והטיפול בפצוע.
- בכל פטירה של פצוע בטראומה.
- בכל מקרה בו אחמ"ש רואה לנכון.

8.3. אופן העבודה בחדר טראומה:

8.3.1. היערכות בעת שגרה:

- 8.3.1.1. באחריות מנהל היחידה לכירורגיה דחופה וטראומה, מנהל המחלקה הכירורגית ומנהל המלר"ד לוודא כי מובילי צוותי הטראומה הינם בעלי הידע וההכשרות המתאימים.
- 8.3.1.2. באחריות ראש צוות טראומה במלר"ד להכשיר ולוודא כי כל אחות המופקדת בטראומה עברה הכנסה לעבודה בטראומה וברשותה הידע וההכשרות המתאימים.

8.3.2. כשירות ומוכנות חדר הטראומה:

- 8.3.2.1. חדר הטראומה יאובזר ויצויד בהתאם לדרישות משרד הבריאות המקובלות בארץ ובעולם.
- 8.3.2.2. אחות ראש צוות טראומה במלר"ד אחראית על בדיקת כשירות ותוקף של הציוד המתכלה והקבוע בחדר הטראומה.
- 8.3.2.3. בכל מקרה של חוסר או תקלה בציוד מציל חיים בטראומה תעדכן ראש צוות טראומה

את:

- האחות הראשית במלר"ד.
- האחות המופקדת לטראומה.
- אחראית המשמרת.
- מוביל צוות טראומה.
- מנהל היחידה לכירורגיה דחופה וטראומה.
- מנהל המחלקה לרפואה דחופה.
- 8.3.2.4. באחריות האחות המופקדת על הטראומה לבדוק בתחילת כל משמרת את חדר הטראומה.
- 8.3.2.5. בכל מקרה של תקלה או חוסר האחות המופקדת על הטראומה תעדכן את אחות אחראית משמרת וראש צוות טראומה.



8.3.2.6. באחריות האחות המופקדת על הטראומה לוודא חזרה של חדר הטראומה למוכנות וכשירות לאחר כל טראומה בהקדם אפשרי, כולל:

- השלמת ציוד מתכלה.
- החזרת ציוד קבוע.
- ניקוי ציוד, מיטה, חדר הטראומה.

8.3.3. הכנת היחידה לקליטת הפצוע:

8.3.3.1. קבלת הדיווח על פצוע יועבר מהגורם המפנה לאחות אחראית משמרת על פי עקרונות ה- MIST, אחראית משמרת תעביר את הדיווח למוקד אשר יצרו קשר עם צוות הטראומה על פי טופס דיווח על פצוע טראומה (נספח 9). במקרה של דיווח על נחיתת מסוק צוות המוקד ישווח על פי טופס דיווח נחיתת מסוק (נספח 10).

8.3.3.2. לאחר קבלת הדיווח וטרם הגעת הפצוע, באחריות מוביל צוות טראומה ואחות טראומה לוודא מוכנות ציוד נדרש והגעת צוות בהתאם לאופי הפציעה.

8.3.3.3. על-פי הצורך, יש להזמין מוצרי דם ללא הצלבה לטראומה.

8.3.3.4. בחדר תרופות תהיינה בכל עת קופסאות עם תרופות שכיחות בשימוש בטראומה, טרם קבלת פצוע יש להציב קופסא בעמדת הטיפול. תרופות נוספות על פי צורך שימוש נמצאות בחדר התרופות.

8.3.3.5. חימום חדר הטראומה.

8.3.3.6. במידה וניתן, יש לבצע תדריך וחלוקת תפקידים לחברי הצוות.

8.3.3.7. במקרה של תינוקות/ילדים, יתקבלו בעמדה 3. יש להכין סרגל Broselow בהשג יד ולוודא זמינות ציוד החייאת ילדים.

8.3.4. רישום הפצוע:

8.3.4.1. קבלת חולים מלר"ד הינם חלק מרשת הדיווח טרם הגעת הפצוע.

8.3.4.2. פקיד קבלת חולים ימתין לפצוע בחדר הטראומה ויוודא כי המערכת מוכנה לקליטת פרטי הפצוע במערכת מחשוב בית החולים.

8.3.4.3. פקיד קבלת חולים יבצע זיהוי הפצוע על-פי הנהלים וייקחו פרטים רלוונטיים.

8.3.4.4. במידה והמצב הרפואי אינו מאפשר קבלת פרטים ירשם הפצוע כאלמוני.

8.3.4.5. בפצוע לא יציב, במידה ותהליך הזיהוי צפוי לקחת יותר מכ-3 דקות (בלי זמן מדויק) הפצוע ירשם כאלמוני.

8.3.4.6. באירוע אשר מגיעים מעל 3 פצועים יחד, על פי שיקול דעת הצוות המטפל הפצועים ירשמו כאלמונים על מנת לזרז את תהליך הרישום.

8.4. עקרונות הטיפול בפצוע בחדר הטראומה:

8.4.1. צוות הטראומה ימתין לפצוע ביחידת הטראומה טרם הגעתו.

8.4.2. עד הגעת הפצוע יש לבצע תדריך וחלוקת תפקידים.

8.4.3. שהות הפצוע ביחידה תהיה קצרה ככל האפשר.

8.4.4. הטיפול על-פי עקרונות ה- ATLS ובהנחיית מוביל צוות טראומה או כונן מיון כירורגיה (במידה ונמצא).

8.4.4.1. סקר ראשוני: בדיקה ראשונית מקיפה על פי עקרונות ה- ATLS בטיפול בפצוע טראומה אשר מטרתו לזהות מצבים מסכני חיים על ידי הקפדה על רצף הבא:

8.4.4.2. בשלב הראשון:



- עצירת דימומים פורצים.
 - דרכי האוויר עם שמירה על יציבות עמוד שדרה צווארי.
 - נשימה.
 - מצב המודינמי.
 - מצב נוירולוגי.
 - חשיפה (הפשטה) וחימום.
 - סקר שניוני: אנמנזה, בדיקה גופנית מקיפה והדמיות.
 - סקר שלישוני: הערכה חוזרת שמטרתה לוודא כי כל הפציעות זוהו וקיבלו מענה מתאים.
- 8.4.5. כל פצוע יחובר למוניטור ויתבצע ניטור רציף לכל הפחות של דופק, ל"ד וסטורציה עד יציאתו מהטראומה.
- 8.4.6. כל פצוע מונשם ינוטר בנוסף בקפנוגרפיה ומד טמפרטורה.
- 8.4.7. ישלחו בדיקות דם:
- 8.4.7.1. פרופיל 156 לגבר ופרופיל 157 לאשה בגיל הפוריות (תוספת בדיקת בטא HCG) (נספח 8)
- 8.4.7.2. דם לסוג והצלבה.
- 8.4.7.3. להדגיש כי בדיקת גזים בדם תבוצע מיידית בחדר המיון (בנוסף לבדיקה במעבדה המרכזית).
- 8.4.7.4. בדיקות נוספות על-פי צורך, לדוגמא: אלכוהול בדם, Toxic screen בשתן טרופונין וכדומה.
- 8.4.8. הקפדה על טיפול בכאב.
- 8.4.9. הקפדה בטיפול על הפשטה מלאה ושמירה על צנעת הפרט. יש לחמם אקטיבית את הפצוע לאחר הפשטתו.
- 8.4.10. הקפדה על הסבר למטופל ומשפחתו ע"י רופא ואחות על הפציעה והמשך תוכנית הטיפול.
- 8.5. דגשים בניהול הטיפול בילדים ותינוקות:**
- 8.5.1. ילד מוגדר מגיל 17 ומטה.
- 8.5.2. אחראית משמרת מלר"ד / אחראית משמרת מלר"ד ילדים יעבירו מידע דו כיווני לגבי טראומה בה מעורבים ילדים.
- 8.5.3. באם התקבל ילד במלר"ד ילדים והוחלט להעבירו לחדר הטראומה, אחות ממלר"ד ילדים תלווה את הפצוע לחדר הטראומה ותחל את הטיפול עד הגעת אחות הטראומה.
- 8.5.4. טיפול בילד בטראומה יתבצע בעמדה 3 ככל הניתן, יש לציין שבכל עמדה יש ציוד לטיפול בילדים.
- 8.5.5. יש לשים לב למכניזם, האם ישנו סיפור המחשיד להתעללות או פגיעה מכוונת ובמידת הצורך לקרוא לעו"ס.
- 8.5.6. מוביל צוות טראומה הוא מנהל הטיפול בפצוע.
- 8.5.7. רופא ילדים ממלר"ד ילדים / טיפול נמרץ ילדים יגיע לטראומה בכל מקרה של טיפול בילד / תינוק.
- 8.5.8. רופא ילדים יסייע לצוות הקבוע להעריך ולטפל בפצוע.
- 8.5.9. על-פי הצורך ובמיוחד כאשר ישנו פצוע קשה, יש לקרוא לתורן טיפול נמרץ ילדים לסיוע בטיפול.
- 8.5.10. באופן קבוע יהיו מגירות ציוד מסודרות על-פי סרגל "ברסלאו" (Broselow tape) ובאחריות ראש צוות טראומה ואחות מופקדת על הטראומה במשמרת לוודא כי הציוד קיים ומסודר.



- 8.5.11. עם ההודעה על קבלת ילד יש להכין את סרגל "ברסלאו" (Broselow tape) בהישג יד.
- 8.5.12. בעת הטיפול, יש לקחת בחשבון את השינויים הפיזיולוגיים ואנטומיים בין ילד ומבוגר, התייצגות שונה של הפגיעות, השוני בערכי המדדים החיוניים התקינים, יתרונות וחסרונות של הדמיות והשוני והמורכבות בביצוע פרוצדורות.
- 8.5.13. במידה והילד/ התינוק בהכרה, יש לשאוף להימצאות מלווה מוכר לצידו מבלי להפריע לרצף הטיפול.
- 8.5.14. במידה ואין מבוגר המלווה את הילד / תינוק, יוצמד איש צוות לפצוע עד הגעת מבוגר. יש לקרוא לעו"ס לצורך סיוע באיתור המשפחה.
- 8.5.15. בעת יציאת תינוק / ילד מחדר הטראומה, מעבר לרשימת תיוג הרגילה, ידווח גם לאחרית במלר"ד ילדים על הממצאים ותכנית הטיפול.
- 8.6. דגשים לטיפול בפצועים מעל גיל 65:**
- 8.6.1. יש לשים לב במכניזם באם ישנו סיפור המחשיד להתעללות או פגיעה מכוונת יש לקרוא לעו"ס.
- 8.6.2. יש להקפיד ולשים לב למחלות נלוות וטיפול תרופתי קבוע, בעיקר אלו המשפיעות על ממדי המטופל ועל טיפול.
- 8.7. דגשים בניהול הטיפול בנשים הרות:**
- 8.7.1. העקרונות בהערכה וטיפול ראשוני באישה בגיל הפוריות ואישה הרה אינם שונים מכל טראומה אחרת.
- 8.7.2. בנשים בגיל הפוריות, טרם חזרת תשובת בטא HCG, יש לשקול את נחיצות ביצוע בדיקות הדמיה הכרוכות בקרינה ואת דחיפותן. והיה ומוביל צוות טראומה מחליט להמתין לחזרת תשובת הבדיקה, והיא מתבררת כחיובית, ישקול את חלופות ההדמיה הקיימות, ויחליט האם לבצע בדיקה הכרוכה בקרינה. יש להסביר למטופלת את ההתוויה לביצוע הבדיקה ואת השלכותיה הצפויות, לקבל את הסכמתה ויש לנקוט באמצעים הנדרשים להגנת העובר (סינר עופרת) במידת האפשר.
- 8.7.3. עד שבוע 24 להריון הכנסה לחדר הטראומה על פי שיקול דעת של הצוות המטפל (רפואי וסיעודי).
- 8.7.3.1. מעל שבוע 24 יש להכניס לטראומה בכל מנגנון פגיעה.
- 8.7.4. פרוצדורות שונות כולל בדיקות הדמיה יבוצעו על-פי הצורך ושיקול דעת. הדמיה באישה הרה יבוצעו על פי הצורך ושיקול דעת תוך כדי נקיטה באמצעים הנדרשים להגנת העובר (סינר עופרת) במידת האפשר.
- 8.7.5. יש לבצע ניטור עוברי לכל אישה מעל שבוע 24, מיקום ביצוע הניטור על פי שיקול דעת רפואי.
- 8.7.5.1. במצב בו יש חשש לפגיעה חמורה באישה או בעובר תוזעק מיילדת לחדר הטראומה והניטור העוברי יבוצע בחדר הטראומה ע"י מיילדת.
- 8.7.6. במקרה שהאישה נמצאת בהחייאה או נקבע מותה, ניתן במקרים מסוימים לבצע ניתוח קיסרי חירום בחדר הטראומה. יש לוודא נוכחות צוות מתאים (כירורג, גינקולוג, רופא ילודים, מיילדת, אח/ות ט.נ ילודים, אח/ות חדר ניותח, עו"ס).
- 8.7.6.1. במקרה בו הוחלט על ניתוח קיסרי חירום מחוץ לחדר הטראומה, מיקום ביצוע יקבע על פי החלטת כון כירורג בכיר ורופא נשים בכיר.
- 8.8. כללים מנחים לאשפוז פצוע:**
- 8.8.1. פצועים אשר עברו הערכה מלאה ונמצאה פגיעה מבודדת למערכת או אזור, ניתן לאשפז לאחר אישור ממוביל צוות טראומה, בכל מחלקה בבית חולים.



8.8.1.1. פצוע הסובל מפגיעה ביותר ממערכת גוף אחת יוגדר כטראומה רב מערכתית במחלקת כרורגיה כללית.

8.8.2. ככלל, ובמיוחד לפצועים עם טראומה מורכבת, יבוצע סקר שלישוני תוך 24 שעות מאשפוז הפצוע ע"י צוות יחידת הטראומה וכירורגיה דחופה.

8.8.3. פצוע הזקוק להתערבות דחופה או מידיית (חדר ניתוח /אנגיו) חייב להיות מאושפז טרם יציאה מחדר הטראומה. במקרה של חילוקי דעות לגבי המחלקה המאשפזת, ההחלטה תתקבל ע"י מנהל יחידת הטראומה / מנהל המלר"ד/ כונן מלר"ד.

8.9. הטיפול הרפואי בפצוע:

8.9.1. על כל רופא לתרום מיכולותיו לצורך הטיפול המיטבי בפצוע על פי עקרונות ה- ATLS ותוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים המטפלים בהנחייתו של הכירורג הכללי הבכיר ביותר הנמצא בחדר הטראומה.

8.9.2. על הרופאים המטפלים להשתלב בטיפול לפי שלבי הטיפול.

8.9.3. כל רופא יקפיד לרשום סיכום של הערכתו, ממצאיו, רושם, תכנית והמלצות בגיליון המטופל.

8.9.4. בכל סוגיה של מחלוקת יש להציג את הנתונים וחווות הדעת לכירורג הכללי הבכיר ביותר וזה יחליט על הערכה/ טיפול נדרש.

8.9.5. חשוב להוריד את הפצוע מוקדם ככל שניתן מקרש גב (במידה וישנו).

8.9.6. במידה וישנו צווארון, הורדתו או הנחייה להשאירו תעשה ע"י אורתופד או כירורג כללי. ככלל חשוב להוריד צווארון מוקדם ככל שניתן.

8.10. עקרונות כללים בהערכה וטיפול בפצוע:

סקטור מטפל	עקרונות כלליים בהערכה וטיפול בפצוע
כירורג כללי	✓ ניהול והובלת הערכה וטיפול בפצוע ✓ תקשורת מתמשכת עם כלל חברי הצוות המטפל
אורתופד	✓ בסקר שניוני בדיקה מדוקדקת אחר פגיעות אורתופדיות וניהולן ✓ תקשורת מתמשכת עם כירורג ונירוכירורג על ממצאים והצורך בהתערבויות ✓ יש לכתוב מגבלות תנועה במידה ויש
נירוכירורגיה	✓ בסקר ראשוני יעזור בהערכה ניורולוגית וישלים הערכה ניורוכירורגית ✓ בסקר שניוני ניהול פגיעות ניורוכירורגיות ✓ תקשורת מתמשכת עם כירורג ואורתופד על ממצאים והצורך בהתערבויות
רדיולוג	✓ יבצע FAST +/- eFAST בעת ביצוע תוספות לסקר ראשוני וידווח על הממצאים לכירורג הכללי ✓ באחריותו להגיע מבעוד מועד לטראומה ולוודא כי מכשיר ה- US זמין ושמיש ✓ עם סיום הערה יוודא כי מכשיר ה- US נקי, חוזר למקומו, מחובר לחשמל ולרשת
מרדים	✓ יעזור בשליטה על A, B ו-C מתוך סכמת הטיפול ✓ לציין כי מעבר לניהול נתיב אויר והנשמה יעזור ב- C בהכנסת לינים, מתן מוצרי דם, תפעול Level-1, ניטור, כולל ניטור חודרני (A-line וכדומה) ✓ ישמור על קשר מתמשך ושת"פ עם הכירורג הכללי
פלסטיקאי	✓ יעזור בהערכה וטיפול בפצוע ע"פ צורך ✓ במקרה של כוויה, ינהל את המקרה לאחר שנשללה טראומה אחרת (קינטית) ע"י כירורג כללי וזה העביר את השליטה בפצוע לפלסטיקאי
רופא ילדים	✓ יכנס לחדר הטראומה בכל מקרה של ילד מתחת לגיל 14 ויעזור בהערכה וטיפול בילד ✓ ישמור על קשר מתמשך ושת"פ עם הכירורג הכללי
רופא מלר"ד	✓ יעזור בהערכה וטיפול בפצוע עפ"י הצורך ✓ יכנס לחדר טראומה במקרים של שאיפת עשן, היפרתרמיה (מכת חום), חשד לאירוע טוקסיקולוגי, חניקה ✓ יעזור בהחייאת פצוע ביחד עם כירורג: הכנסת צנתרים, אינטובציה ✓ יעזור בהערכת פצוע עם חשד לאירוע לבבי או מוחי אשר גרמו לפגיעתו



✓ יקרא לטראומה בכל מקרה של אשה בהריון. ✓ יעזור בהערכה וטיפול בפצועה ✓ יבצע הערכה עוברית כמקובל ✓ ישמור על קשר מתמשך ושת"פ עם הכירורג הכללי ✓ במידה וזקוקה להשגחה בלבד תתאשפז במחלקת נשים ויולדות תוך תאום עם הכירורג הכללי	רופא נשים ומיילדות
✓ יעזור בהערכה וטיפול בפצוע ע"פ צורך בדגש בעת בעייה קשה בניהול נתיב אויר או פגיעה צווארית ✓ ישמור על קשר מתמשך ושת"פ עם הכירורג הכללי ומרדים	א.א.ג
✓ יבצע בדיקות שוטפות למכונת הצילום אשר ממוקמת קבע בטראומה – קיימת, תקינה, מחוברת לחשמל ✓ יבצע צילומים נדרשים בחדר הטראומה ✓ יוודא כי הצילומים מועלים למערכת ה- Pacs של בית החולים ✓ בסיום יוודא כי מכונת הצילום חוזרת למקומה נקיה, מחוברת לחשמל ומוכנה לטראומה הבאה	טכנאי רנטגן

כל סקטור אחר:

- ✓ יקרא עפ"י הצורך לייעוץ בטראומה ויגיע בהקדם אפשרי
- ✓ ישמרו על קשר מתמשך ושת"פ עם הכירורג הכללי

8.11. העברת פצוע מחדר הטראומה ליעדים שונים בתוך בית החולים ACC 2.3 ME 3:

- 8.11.1. הוצאת הפצוע מהטראומה תתאפשר רק באישור מוביל צוות טראומה.
- 8.11.2. ההחלטה על ליווי פצוע בסמכות מוביל צוות טראומה.
- 8.11.3. העברת פצוע מחדר הטראומה מחייבת ליווי של צוות מטפל עפ"י [נוהל העברת מטופל קריטי](#), מספר: 02-02-11-05, העברה ללא ליווי באישור מוביל צוות טראומה.
- 8.11.4. העברת מידע טרם העברת פצוע למסגרת המקבלת תתבצע על פי מודל המרא"ה.
- 8.11.5. יש לדאוג לרשום ודיווח ברשומה הרפואית והסיעודית בהקדם האפשרי.
- 8.11.6. טרם היציאה, תבוצע הערכת מצב ורישום מדדים.
- 8.11.7. אחות הטראומה תדווח לאחמ"ש על יציאת הפצוע מחדר הטראומה.
- 8.11.8. פצוע הזקוק להתערבות בהולה יש להעזר בצוות הביטחון לצורך פינוי פרודורים והחזקת מעליות.

8.12. החזרת יחידת הטיפול לכשירות לאחר יציאת הפצוע:

- 8.12.1. באחריות האחות המופקדת בטראומה.
- 8.12.2. השלמת הצידוד בעמדה לפי השימוש במהלך הטיפול.
- 8.12.3. עדכון ראש צוות טראומה בדבר חסרים של צידוד שאין יכולת להשלימם ברגע נתון.

9. הכשרה והטמעה

- 9.1. הנוהל יופץ לצוותים במלר"ד במייל ועל-ידי המנהל הישיר.
- 9.2. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן באוריינטציה בעת התחלת עבודה בחדר הטראומה.



נספח 13: עדכוני הנוהל

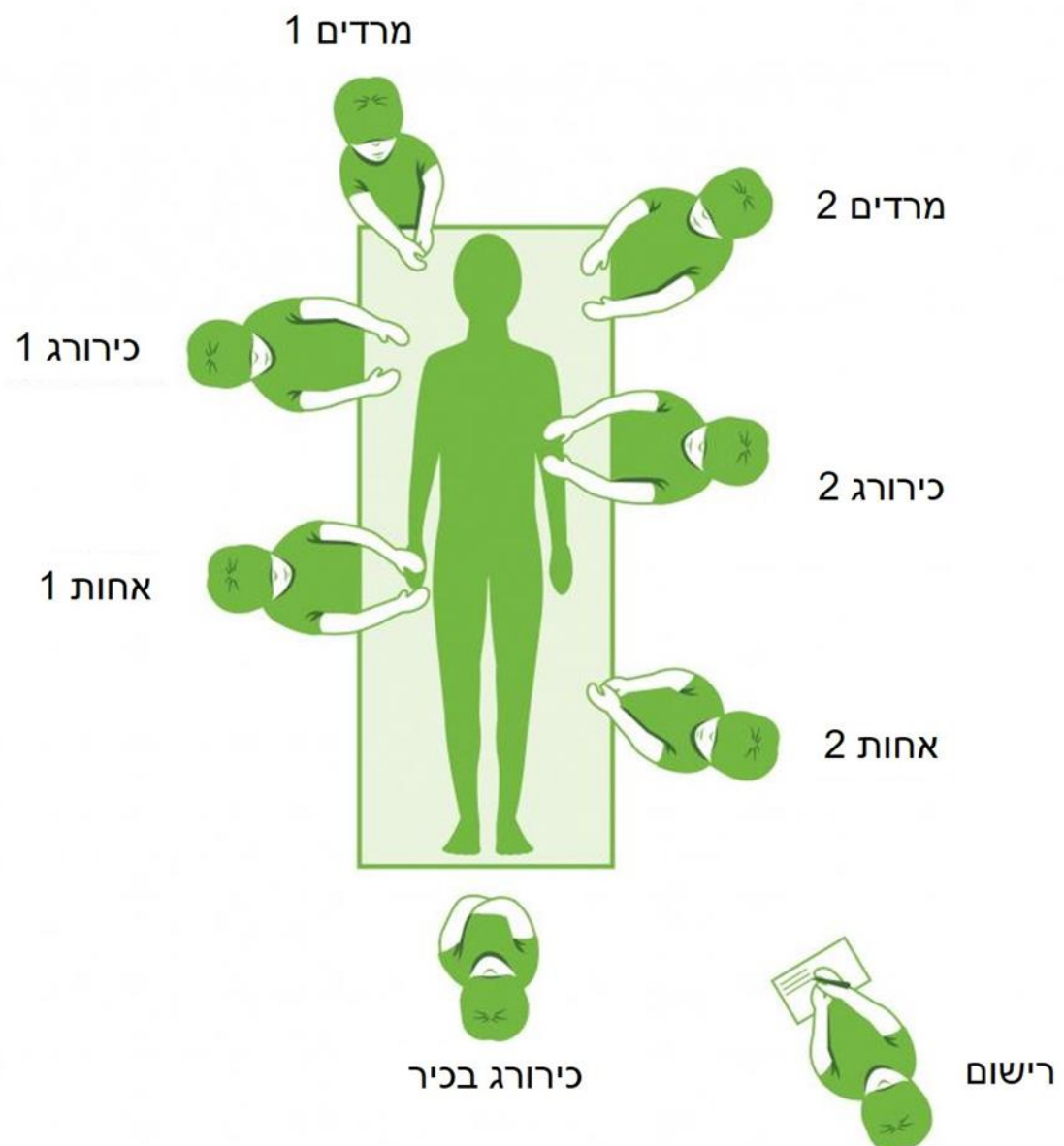
מהדורת הנוהל	תאריך פרסום	עדכוני הנוהל
שניה		שינוי נרחב

היסטורית כתיבה ואישור הנוהל

מהדורה	תאריך פרסום	כותבי ומעדכני הנוהל	אישורי הנוהל
ראשונה	יוני 2022	פרופ' מיקלוש באלה מנהל יחידת הטראומה, דר' שלי אשכנזי אחות ראשית טיפול נמרץ נשימתי, דר' אסף קידר רופא בכיר יחידת הטראומה, רות שפיגל ראש צוות טראומה, אהרן מנדלבוים ראש צוות טראומה	דר' ינון בודה מנהל בית החולים ע"כ, דר' רלי אלון סמנכ"לית סיעוד ומקצועות הבריאות, פרופ' קובי אסף מנהל המחלקה לרפואה דחופה ע"כ, פרופ' אלון פיקרסקי מנהל האגף הכירורגי, דר' מיקלוש באלה מנהל יחידת הטראומה, דר' שלי אשכנזי אחות ראשית טיפול נמרץ נשימתי, דר' אסף קידר רופא בכיר יחידת הטראומה, רות שפיגל ראש צוות טראומה, אהרן מנדלבוים ראש צוות טראומה



נספח 2: עמדות צוות הטראומה ביחידת הטראומה



נספח 6: קריטריונים לקבלת פצוע לטראומה ACC 2.3 ME 1

קריטריונים פיזיולוגיים		
לא ניתן לחמצן או לאוורר כראוי מונשם או עם עזרי הנשמה		נתיב אויר
כל סימן לאי ספיקה נשימתית היפוקסיה, שימוש בשרירי עזר מספר נשימות >10 או <29 לדקה		נשימה
לחץ דם (סיסטולי) על-פי קבוצות גיל:	כל סימן שאינו בנורמה מילוי קפילרי יותר מ 2 שניות לחץ דם נמוך לגיל לחץ דם $\geq 90\text{mmHg}$ (גיל <10 שנים)	המודינאמיקה
<60		
גיל $2X + 70 <$ <90		
פחות משנה 1-10 שנים <10 שנים		
על פי AVPU GCS 13 ומטה ; ניקוד מוטורי ב GCS 5 ומטה		חסר נוירולוגי
התדרדרות פצוע נזקק למנות דם בדרך לבית החולים		
קריטריונים אנטומיים		
✓ פגיעה חודרת לראש/צוואר, גו (טורסו), גפיים פרוקסימלית למרפקים או ברכיים ✓ שבר פתוח או דחוס בגולגולת ✓ שיתוק או חשד לפגיעה בחוט השדרה ✓ שבר באגן ✓ Flail Chest ✓ אמפוטציה פרוקסימלית לשורש כף יד ולקרסול ✓ שבר בעצם ארוכה (Femur or humerus) ✓ מעיכה, ריסוק או קריעה של גפה		
מכניזם		
✓ נפילה של מבוגר יותר מ 3 מ' או ילד יותר מ 2 מ' או 3X גובה הילד ✓ נפילה מכל גובה באדם שלוקח מדללי דם (להדגיש כולל גובה עצמו) ✓ סיכון גבוה לפגיעה מהתרסקות מכונית: ○ נוסע שעף מהרכב ○ מוות של איש נוסף בתאונה ✓ מכונית מול הולך רגל: פגיעת רכב בהולך רגל, או ברוכב אופניים (במהירות העולה מעל 20 קמ"ש) ✓ תאונת אופנוע במהירות העולה על 20 קמ"ש ✓ פגיעה עם אנרגיה גבוהה או עצירה פתאומית כגון: פיצוץ מכונית, האטה פתאומית, אדם שעף מאופנוע או מכונית ✓ פגיעה מחשמל באנרגיה גבוהה ✓ כווייה מעל 10% דרגה 2-3 ו/או שאיפת עשן ✓ חשד להיפותרמיה, טביעה, תליה ✓ חשד לטראומה מכוונת ✓ החלטת הגורם המפנה ✓ כל פינוי מוסק של פצוע כולל התייבשות, מכת חום, תלייה וכדומה ✓ חבלה קשה לבטן עם כאב עז או סימני גירוי צפקי ✓ אישה בהריון		



נספח 7: קריטריונים לקריאה לעובדת סוציאלית-לחדר הטראומה

1. רקע:

המצב הרגשי בו נתון נפגע טראומה ובני משפחתו מאופיין ב: בלבול, אובדן שליטה, פחד, חרדה. אלו מצבים המקשים על המשפחה לחשוב על דרכי התארגנות במצב החדש ועל קליטת המידע שניתן למשפחה בזמן הטיפול. חלק מנפגעי הטראומה מגיעים כאלמונים. רובם מגיעים ללא בני משפחה קרובים.

2. מטרה: קביעת כללי טיפול בנפגע טראומה ובני משפחתו.

3. סמכות: בסמכות הצוות הרפואי והסיעודי, לקרוא לעובד סוציאלי לטיפול בנפגע טראומה ו/או בני משפחתו.

4. אחריות: באחריות אחות אחראית משמרת לקרוא לעובד סוציאלי.

האחריות למתן מענה מצד העובדים הסוציאליים: בשעות העבודה הרגילות. מחוץ לשעות העבודה - על העו"ס הכון.

5. קריטריונים לקריאה לעובד סוציאלי לטיפול בנפגע טראומה ובני משפחה על-פי שיקול דעת אחות אחראית משמרת:

- א. אירוע עם מספר נפגעים (על פי חומרת ונסיבות הפגיעה);
- ב. אירוע בו מעורבים מספר בני משפחה. (ת.ד, שריפה, תאונה ביתית וכד');;
- ג. תגובות רגשיות קשות של מלווים או בני משפחה;
- ד. חשד לאוכלוסייה בסיכון (אלימות והזנחה בקטינים, נשים, קשישים, חסר ישע);
- ה. **בכל** אירוע פח"ע;
- ו. לבקשת הפצוע/המשפחה;
- ז. במקרים בהם הפצוע אלמוני;
- ח. שכול פתע;
- ט. לשיקול דעת האחיות בטרומה.

6. שיטה:

- א. העובדת הסוציאלית תעודכן על פצוע מורכב/ קשה על-פי שיקול דעת אחות טראומה מוקדם ככל האפשר.
- ב. העו"ס תסייע למשפחה וקרובי הפצוע.
- ג. העובדת הסוציאלית תרכז את הסיוע להתמודדות עם מצבי אבל ומצבי דחק נפשי במקרים של פטירה.
- ד. העובדת הסוציאלית תהיה שותפה במסירת המידע למשפחתו של הפצוע, בשיתוף עם הצוות הרפואי והסיעודי.

**נספח 8: בדיקות דם בחדר טראומה**לכל פצוע ישלח באופן שגרתי:

1. לבנק הדם: דם דגימה לסוג והצלבה, שתי מבחנות חתומות ע"י שני מטפלים
2. גזים בדם (וריד): לבדיקה מיידית בחדר מיון
3. למעבדה המרכזית: פרופיל בדיקות על-פי הפרוט הבא:

א. פרופיל 156 (156P) לגברים:▪ ביוכימיה:

- אלקטרוליטים
- תפקודי כליה
- Total bilirubin
- Diastase
- Lactate

▪ גזים בדם (וריד)

▪ ספירת דם

▪ תפקודי קרישה (PT, PTT, INR, Fibrinogen)

ב. פרופיל 157 (157P) לנשים בגיל הפוריות:

▪ זהה לפרופיל 156 (לגברים) ובנוסף Beta-HCG, בדיקת הריון בדם

4. על-פי הצורך ישלחו בדיקות נוספות, לדוגמא:

- שتن ל-Tox Screen בחשד רלונטי
- אלכוהול בדם בחשד רלונטי
- Troponin בחשד לקונטוזיה לבבית, מאורע לבבי או אחר
- CPK בחשד לפגיעות מעיכה
- Carboxyhemoglobin (HbCO) בחשד להרעלת Carbon Monoxide (CO)
- Calcium בעת מתן מוצרי דם